

SH.GSR.06.ICD.11			رقم السياسة
تقييم أخطار قرح الفراش وتفاذيتها			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
١٣	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الاقسام بالمستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة		إعداد
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي		مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوى

السياسة

- يلتزم فريق التمريض بمستشفى صيدناوى بتقييم حالة وسلامة الجلد لجميع المرضى عند دخولهم المستشفى لمعرفة مدى درجة تعرضهم لقرح الفراش وتحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة بقرح الفراش واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث قرح الفراش للمرضى والتقليل منها والمساعدة في التئامها للمرضى المصابين بها فعلياً.
- يلتزم العاملون بوضع خطة مصممة خصيصاً للمريض المعرض للسقوط ومسجلة ب ملف المريض، كما يلتزم جميع العاملين ب تنفيذ بنود الخطة

الغرض

تحقيق سلامة وأمان المريض بالمستشفى عن طريق منع حدوث قرح الفراش.

التعريفات

قرح الفراش: هو إصابة تحدث في الجلد نتيجة عدم تدفق الدم بشكل سليم والحك المستمر في الجلد من منطقة عظمية في الجسم وذلك لأن الجلد يكون تحت الضغط من الفراش أو أي سطح غير مرن لفترة طويلة

إجراءات العمل

١. تقييم حالة الجلد وتقييم أخطار التعرض لقرح الفراش:
- تقوم الممرضة بتقييم حالة الجلد وتقييم أخطار التعرض لقرح الفراش لكل مريض عند دخوله بالأقسام الداخلية والعنايات المركزة باستخدام نموذج التقييم التمريضي عند دخول المريض.
 - تقوم الممرضة بفحص الجلد عند النتوءات العظمية الموجودة في جميع أجزاء الجسم مثل (الكعب، المفصل بين الساق والقدم، عظام الحوض، عظمة العصعص، الأذن، الأكتاف، الكوع).
 - تقوم الممرضة بفحص المناطق التي بها احمرار بجلد المريض بشرط ألا يزول الاحمرار في خلال ٣٠ دقيقة وفي حال إذا كان المريض ذو بشرة داكنة يمكن فحص الجلد بواسطة تدفئة هذه المناطق أو شكوى المريض من وجود ألم بالجلد عند النتوءات العظمية.

- في حالة وجود قرح فراش بالمريض عند الدخول يتم تعريف المريض وأسرته وأخذ توقيع المريض أو ذويه على إقرار بوجود قرحة فراش مع توضيح مكان القرحة والدرجة والحجم وجود الإفرازات، وفي حالة رفض المريض يتم عمل نموذج (OVR) وتسجيل الواقعة في ملاحظات التمريض
- ❖ في حالة وجود قرح فراش بالمريض عند الدخول يتم عمل الآتي:
- يتم كتابة نموذج اقرار وجود قرح الفراش خارج المستشفى
- يقوم الطبيب في حالة الحاجة إلى طبيب تجميل بعمل طلب عرض استشارة.

٢. يتم التقييم باستخدام NORTON Scale للبالغين

٣. يتم استخدام BRADEN Scale للأطفال

٤. للأطفال حديثي الولادة يتم استخدام NSRAS scale

٥. الإطار الزمني لاستكمال مسح قرح الفراش:

- تقوم الممرضة باستكمال فحص قرح الفراش خلال ساعتين من دخول المريض للقسم وتسجله في نموذج التقييم التمريضي للبالغين عند الدخول والتقييم التمريضي للأطفال عند الدخول
- إعادة تقييم حالة الجلد وتقييم مخاطر التعرض لقرح الفراش: تقوم الممرضة بإعادة التقييم مرتين يوميا صباحا ومساء بنموذج التقييم التمريضي اليومي للمرضى البالغين والأطفال. وإعادة تقييم عند النقل من قسم ل قسم قبل استلام المريض

٦. في حالة المرضى المعرضين لقرح الفراش:

- عمل خطة لرعاية جلد المريض:

○ تقوم الممرضة بعرض نتائج تقييم حالة الجلد وتقييم مخاطر التعرض لقرح الفراش عند

الدخول على الطبيب.

○ يتم إبلاغ أخصائي التغذية لوضع خطة تغذية عالية البروتين وكثرة السوائل المعطاة للمريض

إذا لم يكن هناك مانع صحي في ذلك.

- تقوم الممرضة بوضع خطة تمريضية لتقليل أو منع ضغط النتوءات العظمية على جلد المريض وتقليل الاحتكاك بين الجلد والأسطح الأخرى، ومنع أو تقليل تعرض الجلد للبلل أو الرطوبة.
- تقوم الممرضة بعمل تثقيف صحي للمريض وذويه.
- تقوم الممرضة بعمل خطة لتقليب المريض كل ساعتين أو حسب أوامر الطبيب.
- التعامل مع المريض المعرض للإصابة بقرح الفراش
 - تقوم الممرضة بتنفيذ جدول وتقليب المريض كل ساعتين وتوثيق تقلب المريض في جدول تقلب المريض بالملف الطبي.
 - تقوم الممرضة باستخدام ملاءة تحريك وتقليب المريض الغير قادر على الحركة.
 - تقوم الممرضة باستخدام وسادات لوضعها عند النتوءات العظمية مثل (الكعب، الركبة، الكاحل) لمنع حدوث اتصال أو احتكاك مباشر بينها.
 - تقوم الممرضة بوضع مرتبة هوائية أسفل المريض الغير قادر على الحركة طبقاً لأوامر الطبيب.
 - تقوم الممرضة برفع كاحل المريض بواسطة الوسادات
 - تقوم الممرضة باستخدام ملينات للجلد حسب أوامر الطبيب لتقليل الإصابات الناتجة عن الاحتكاك كذلك تعمل على تقليل العوامل البيئية التي تزيد من جفاف الجلد مثل قلة الرطوبة، الهواء البارد باستخدام مرطبات للجلد.
 - تعمل الممرضة على تجنب عمل تدليك على أماكن النتوءات العظمية.
 - تقوم الممرضة بتنظيف الجلد بمجرد تلوثه وبطريقة روتينية.
 - تقوم الممرضة بتشجيع المريض على شرب حوالي ٨ أكواب من السوائل يومياً بشرط عدم تعارض ذلك مع الحالة الصحية للمريض.
 - تقوم الممرضة بمساعدة المريض في زيادة نشاطه الحركي من خلال عمل التمرينات له.

○ تقوم الممرضة بعمل تنقيف صحي للمريض وذويه عن منع حدوث قرح الفراش وتسجيله في

نموذج التنقيف الصحي

٧. في حالة المرضى غير المعرضين لقرح الفراش

○ تقوم الممرضة بإعادة تقييم حالة الجلد وتقييم أخطار التعرض لقرح الفراش مرتين يوميا صباحا ومساء.

○ تقوم الممرضة بملاحظة جلد المريض لاكتشاف أي منطقة من الجلد يظهر بها احمرار ويتم توثيق ذلك في نموذج التقييم التمريضي اليومي ونموذج ملاحظات التمريض وخطة الرعاية التمريضية.

○ تقوم الممرضة بعمل تقرير حدث غير متوقع (OVR) وتسليمه لقسم الجودة في حالة العثور على قرحة فراش أو احمرار بالجلد المريض غير مصاب قرحة فراش عند الدخول وتقوم باستدعاء الطبيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المريض ومنع تطور القرحة

المسؤول عن التنفيذ

- الأطباء.
- أفراد هيئة التمريض
- فريق الجودة: التدريب على السياسة ومتابعة التنفيذ و التحسين

المراقبة والتقييم

- KPI : يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تقوم المستشفى بمتابعة وجمع وتحليل والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بعملية تقييم قرح الفراش و تفاديها
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية تقييم قرح الفراش و تفاديها

النماذج / المرفقات

- نموذج تقليب المريض.
- نموذج التقييم التمريضي عند الدخول
- نموذج التقييم التمريضي اليومي للمرضى
- إقرار قرح الفراش.
- نموذج أحداث غير متوقعة.
- نموذج التثقيف الصحي

معايير ذات صلة

المراجع

دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، إصدار ٢٠٢٥ . معيار ICD.1١

[illegible]

تقييم أخطار قرح الفراش وتفاذيها الصفحة ٦



الهيئة العامة للتأمين الصحي
قسم:
فرع:
المستشفى:
اسم المريض:
رقم الملف الطبي للمريض:
القسم المعالج:

التقييم التمريضي عند دخول المريض (للبالغين)

القسم: التاريخ: / / الوقت: الممن:
التشخيص الطبي عند الدخول:

تعليمات للمريض

- محتويات الغرفة ☐ مكان الحمام وأضواء الطوارئ ☐
نظام نداء التمريض ☐ مكان الانتظار ووقت الزيارة ☐
شرح نظام حفظ الامانات بالمستشفى ☐ التعليمات الخاصة بعدم التدخين ☐
أسورة التعريف ☐ شرح احتياطات منع خطر السقوط ☐
هل أنت مدخن؟؟ لا ☐ لا في السابق ☐ نعم عدد السنوات: عدد السجائر اليومية:
هل تعرف المريض على حقوق المريض ومسئولياته؟ نعم ☐ لا ☐

التقييم التغذوي

١. فحص الفم: ☐ رطب (٠) ☐ جاف (١) ☐ مصاب (١)
٢. التاريخ المرضي: ☐ قن وغثيان (١) ☐ صعوبة في البلع (٢) ☐ انخفاض الوزن بدون رجيم (٣)
☐ تغذية بالرايل (٣) ☐ تغذية بالمحاليل الوريدية (٣)
٣. الشهية: ☐ عادية (٠) ☐ أقل من المعتاد (١) ☐ مفقودة (٢)
٤. الأسنان: ☐ طقم اسنان (٠) ☐ لا يوجد اسنان مفقودة (٠) ☐ أسنان مفقودة (١)
- مريض الشيخوخة أكثر من ٧٠ سنة دخول عمليات (١)
- سيدة (حامل - رضاعة) (١)
- وصف الغذاء: ☐ عادي (٠) ☐ لين (١) ☐ سوائل (٢) / درجة تقييم التغذية: (لو التقييم أكثر من ٤ يتم إبلاغ الطبيب)
وجود ألم: نعم ☐ لا ☐ مكان الألم: الوقت:

تقييم حالة الجلد

تماسك الجلد: صحي ☐ مجعد ☐ بقع حمراء ☐ قرح سكر / قرح فراش ☐ جرح غير ملتئم ☐	المكان	الحجم/ الدرجة	اللون	الانفrazات

تقييم مخاطر التعرض لقرح الفراش Norton Scale

درجة التقييم	٤	٣	٢	١
الحالة الصحية	جيدة	متوسطة	ضعيفة	سيئة جدا
الحالة العقلية	واعي ومنتهبه	لامبالي	مشتمت	غير واع/غير مدرك
النشاط	يتحرك بدون مساعدة	يتحرك بمساعدة	يتحرك بمساعدة أجهزة (كرسي متحرك)	غير قادر على الحركة
امكانية الحركة	كاملة	ضعيفة	محدودة جدا	لا يتحرك
السلس البولي	لا يوجد	احيانا	بولي عادة	التبول والتبرز
الاجمالي				
	☐ أكثر من ١٨ احتمالية منخفضة ☐ من ١٤-١٨ احتمالية متوسطة ☐ من ١٠-١٣ احتمالية عالية ☐ أقل من ١٠ احتمالية عالية جدا			

إجراءات وقاية المريض من قرح الفراش

م	الاجراءات الوقائية	ضع علامة (صح)
١	ضع المريض على مرتبة هوائية	
٢	قم بتقليب المريض كل ساعتين	
٣	ذلك جلد المريض وضع مرطبات وفقا لتعليمات الطبيب	
٤	اعد تقييم جلد المريض كل ساعتين في نموذج تقييم المريض	

NR, NR, 1=2



اسم المريض :
رقم الملف الطبي للمريض:
القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع:
المستشفى:

التقييم التمريضي للأطفال عند الدخول

اسم الطبيب: التاريخ: / /
الوقت: السن:
النبض: الضغط: التنفس: الحرارة:
الحساسية: الوزن: النوع:
التشخيص الطبي عند الدخول:

تعليمات لأهل المريض

- ☐ محتويات الغرفة ☐ مكان الحمام وأضواء الطوارئ نظام نداء ☐ التمريض مكان الإنتظار ☐ وقت الزيارة
☐ شرح نظام حفظ الامانات بالمستشفى ☐ التعليمات الخاصة بعدم التدخين ☐ أسورة التعريف ☐ شرح الاحتياطات لمنع خطر السقوط
هل عرفت حقوق المريض ومسئولياته لأهل المريض؟ ☐ نعم ☐ لا

تقييم حالة الجلد

تماسك الجلد: ☐ صمى ☐ مجعد ☐ قرح سكر / قرح فراش ☐ جرح غير منقسم ☐ أخرى

المكان	الحجم/ الدرجة	اللون	الإفرازات

عوامل الخطورة	تقييم قرح الفراش للأطفال (Braden SCORE)			
الاحساس بالضغط والآلم	١ (غير موجود نهائيا) - عدم القدرة على الاحساس نتيجة اضطراب بدرجة الوعي او التخدير	٢ (احساس محدود) تماما - استجابة للآلم وفقدان الاحساس بنصف الجسم	٣ (احساس محدود جزئيا) - القدرة على الاستجابة للألم الشفهية مع فقدان الاحساس في واحد او اثنين من الأطراف	٤ (احساس جيد) - استجابة للألم الشفهية ولا يوجد فقدان للاحساس بأي جزء من الجسم
درجة تعرض الجلد للرطوبة	١ (معرض باستمرار) الجلد معرض باستمرار للرطوبة بسبب البول والعرق وغيره	٢ (معرض غالبا) الجلد معرض غالبا للرطوبة ويجب تغيير غطاء السرير مرة كل شيفت	٣ (معرض أحيانا) الجلد يتعرض أحيانا للرطوبة او البهل ويجب تغيير غطاء السرير مرة على الأقل يوميا	٤ (نادر التعرض) الجلد جاف غالبا ونادرا ما يتعرض للرطوبة ويتم تغيير غطاء السرير بشكل روتيني
درجة النشاط الجسماني	١ ملازم الفراش	٢ حركة بالكروسي عدم القدرة على الوقوف او المشي الا بمساعدة الكرسي المتحرك	٣ (بمشي أحيانا) يستطيع المشي أحيانا مسافة قصيرة جدا مع او بدون مساعدة و يقضي معظم اليوم على الكرسي او السرير	٤ (بمشي كثيرا) يستطيع المشي خارج الغرفة بمفرده على الأقل مرتين يوميا وداخل الغرفة كل ساعتين
القدرة على التحكم وتغيير وضع الجسم	١ (غير قادر على الحركة نهائيا) غير قادر على تغيير وضع الجسم او تحريك أحد أطرافه بدون مساعدة	٢ (القدرة على الحركة محدودة تماما) أحيانا يستطيع القيام بحركة طفيفة لأحد أطرافه ولكن معظم الوقت غير قادر على الحركة	٣ (قادر على الحركة جزئيا) يستطيع تحريك الأطراف وتغيير وضع الجسم مرات متعددة	٤ (يستطيع الحركة بشكل طبيعي) يتحرك دائما بشكل طبيعي وبدون مساعدة
التغذية	١ (ضعيفة جدا) لإكمال وجبة كاملة ويعتمد في التغذية على المحاليل الوريدية	٢ (غير كافية) نادرا ما يأكل وجبة كاملة ويشكل عام يأخذ نصف الطعام المقدم له وأحيانا تكون التغذية بشوية رائل	٣ (كافية) يأكل أكثر من نصف الطعام المقدم له ويأخذ حوالي ٤ وجبات يوميا او يتغذى عن طريق الأنبوبية او تغذية وريدية كاملة	٤ (ممتازة) يتغذى بشكل جيد ويكمل وجباته وأحيانا يأكل بين الوجبات بشكل طبيعي
القدرة على الحركة في الفراش او الكرسي (تأثيره على احتكاك الجلد)	١ (صعبة جدا وتسبب مشكلة) يحتاج الى مساعدة كاملة لحمله وتحريكه في السرير وكثيرا ما ينزل على السرير او أثناء الجلوس على الكرسي ولا يستطيع تعديل وضعه/احتكاك للجلد دائما	٢ (صعبة جزئيا) يتحرك بصعوبة مع القدرة أحيانا على التقلب والحركة وتعديل وضعه احتكاك أقل للجلد	٣ (لا توجد مشكلة) لا توجد مشكلة يتحرك في السرير او الكرسي بشكل جيد بدون مساعدة لا يوجد احتكاك للجلد	الاجمالي: عالي الخطورة = ٩ او أقل خطورة شديدة = ١٠ - ١٢ خطورة متوسطة = ١٣ - ١٤ خطورة بسيطة = ١٥ - ١٨

MR.NR.1-2



اسم المريض :
 رقم الملف الطبي للمريض:
 القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
 فرع:
 المستشفى:

نموذج التقييم التمريضي اليومي للمرضى البالغين

تاريخ الدخول: / / القسم:

التشخيص:

التاريخ		ص		م		ص		م		ص		م		ص		م	
الحركة																	
- يتحرك بدون مساعدة (٤)																	
- يتحرك بمساعدة جهاز أو شخص (٣)																	
- ملازم المقعد (٢)																	
- ملازم الفراش (١)																	
الادراك																	
(مدرک / غير مدرک)																	
الوعي																	
درجة التقييم (.....)																	
(واعى (١٥-١٣) / شبه واعى (٩-١٢)																	
غيبوبة (٨-٣) /																	
غير مستجيب (٣)																	
التغذية																	
(٤-٠)																	
السقوط																	
أقل من ٣: احتمالية سقوط منخفض																	
أكثر من ٤: احتمالية سقوط عالية																	
درجة تقييم مخاطر قرح الفراش																	
أكثر من ١٨																	
احتمالية منخفضة																	
١٨ - ١٤																	
احتمالية متوسطة																	
١٣ - ١٠																	
احتمالية عالية																	
أقل من ١٠																	
احتمالية عالية جدا																	
تقييم حالة الجلد																	
اسورة التعريف																	
(موجودة/ غير موجودة)																	
العناية بالوصلات																	
(تم التغيير والحفاظ عليها من الانفصال)																	
التوقيع																	

ملحوظة: يتم الرجوع للتقييم التمريضي عند الدخول في حالة الاحتياج إلى معرفة طريقة التقييم

MR.NR.1-2



اسم المريض :

الهيئة العامة للتأمين الصحي

رقم الملف الطبي للمريض:

فرع:

القسم المعالج :

المستشفى:

نموذج التقييم التمريضي اليومي للأطفال

تاريخ الدخول: / /

التشخيص:

التاريخ									
م	ص	م	ص	م	ص	م	ص	م	ص
الحركة - يتحرك بدون مساعدة (٤) - يتحرك بمساعدة جهاز أو شخص (٣) - ملازم المقعد (٢) - ملازم الفراش (١)									
الانذار (مدرک / غير مدرک)									
درجة تقييم الوعي (.....) (واعى (١٥-١٣) / شبه واعى (١٢-٩) غيبوبة (٨-٣) / غير مستجيب (٣)									
التغذية (٤-٠)									
تقييم حالة الجلد									
اسورة التعريف (موجودة/ غير موجودة)									
درجات تقييم مخاطر قرح الفراش									
عالي الخطورة = ٩ أو أقل خطورة شديدة = ١٠ - ١٢ خطورة متوسطة = ١٣ - ١٤ خطورة بسيطة = ١٥ - ١٨									
العناية بالوصلات (تم التغيير والحفاظ عليها من الاتصال)									
التوقع									

ملحوظة: يتم الرجوع للتقييم التمريضي عند الدخول في حالة الاحتياج الى معرفة طريقة التقييم

تقييم حالة الجلد

تماسك الجلد ☐ صحي ☐ مجعد ☐ يقع حمراء ☐ قرح سكر/ قرح فراش ☐ جرح غير ملتئم ☐ أخرى:

تقييم التغذية:

* فحص : الفم رطب (٠) جاف (١) مصاب (١) * وصف الغذاء (عادي (٠) / لين (١) / سائل (٢))

* التاريخ المرضي: قن وغثيان (١) صعوبة في البلع (٢) انخفاض الوزن بدون رجيم (٣)

تغذية بالرايل (٣) تغذية بالمحاليل الوريدية (٣)

* الشهية : عادية (٠) أقل من المعتاد (١) مفقودة (٢)

* الاسنان : طقم اسنان (٠) لا توجد اسنان مفقودة (٠) اسنان مفقودة (١)

(إذا كان التقييم أكثر من ٤ يتم إبلاغ الطبيب)

قياس درجة الوعي: Glasco coma scale

* استجابة العين (تلقائي (٤) / للكلام (٣) / للام (٢) / لا توجد رد فعل (١)

* الاستجابة اللفظية (واعى (٥) مدروخ (٤) كلمات غير مناسبة (٣) غير مفهوم (٢) لا استجابة (١)

* الاستجابة الحركية (يطيع الاوامر (6) يحدد المؤثر الخارجى (5) يسحب من المؤثر (4) / انكماش غير طبيعى (3) ممدد جسده بطريقة غير طبيعية (2) / لا استجابة (1)

* المجموع Score واعى (١٥-١٣) ، شبه واعى (١٢-٩) ، غيبوبة (٨-٣) ، لا يستجيب (٣)

MR.NR.1-2



اسم المريض :
 رقم الملف الطبي للمريض:
 القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
 فرع :
 المستشفى :

نموذج التقييم التمريضي اليومي للأطفال (ICU)

تاريخ الدخول: / /
 التشخيص:

التاريخ		ص		م		ص		م		ص		م		ص	
الحركة															
- يتحرك بدون مساعدة (٤)															
- يتحرك بمساعدة جهاز أو شخص (٣)															
- ملازم المقعد (٢) - ملازم الفراش (١)															
الادراك (مدرك / غير مدرك)															
درجة تقييم الوعي (.....)															
(واعى (١٣-١٥) / شبه واعى (٩-١٢) / غيبوبة (٣-٨) / غير مستجيب (٣)															
التغذية (٤-٠)															
تقييم حالة الجلد															
اسورة التعريف (موجودة / غير موجودة)															
درجة تقييم مخاطر قرح الفراش															
عالي الخطورة = ٩ أو أقل															
خطورة شديدة = ١٠ - ١٢															
خطورة متوسطة = ١٣ - ١٤															
خطورة بسيطة = ١٥ - ١٨															
العناية بالوصلات															
(تم التغيير والحفاظ عليها من الانفصال)															
التوقع															

ملحوظة: يتم الرجوع للتقييم التمريضي عند الدخول في حالة الاحتياج الى معرفة طريقة التقييم

تقييم حالة الجلد

صحى ☐ مجعد ☐ بقع حمراء ☐ قرح سكر / قرح فراش ☐ جرح غير ملتئم ☐ أخرى

تقييم التغذية :

٧. فحص : الفم رطب (٠) جاف (١) مصاب (١) * وصف الغذاء (عادي (٠) / لين (١) / سائل (٢))
 ٨. التاريخ المرضى: قى وغثيان (١) صعوبة فى البلع (٢) انخفاض الوزن بدون رجيم (٣)
 ٩. تغذية بالرايل (٣) تغذية بالمحاليل الوريدية (٣)
 ١٠. الشهية : عادية (٠) أقل من المعتاد (١) مفقودة (٢)
 ١١. طعم اسنان (٠) لا توجد اسنان مفقودة (٠) اسنان مفقودة (١)
- (إذا كان التقييم أكثر من ٤ يتم إبلاغ الطبيب



اسم المريض:.....
رقم الملف الطبي للمريض:.....
القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع:
المستشفى :

إقرار وجود قرح فراش قبل دخول المستشفى

أقرأنا الموقع أدناهوصلة قرابتي.....

بأن المريض تاريخ دخوله المستشفى: / /

تم دخوله للمستشفى وهو يعاني من قرح فراش في.....

.....
.....

إسم المريض :.....

التوقيع :.....

رقم البطاقة :.....

إسم الطبيب :.....

التوقيع:.....

نموذج الأحداث غير المتوقعة

الهيئة العامة للتأمين الصحي
 فرع :
 مستشفى :



OCCURRENCE VARIANCE REPORT (OVR)

(.....) OVR Code No.

THIS FORM SHOULD BE FORWARDED TO THE QUALITY DEPARTMENT WITHIN 72 HOURS

يجب أن يسلم النموذج لقسم الجودة في خلال 72 ساعة

Reported by Name (OPTIONAL): اسم المبلغ (اختياري)		Department: القسم	
Reported by Signature: توقيع المبلغ		Date of Reporting: تاريخ التبليغ	

INDIVIDUAL OR MEMBER OF STAFF INVOLVED (Tick One or More)

☐ Nurse ممرضة	☐ Physician طبيب	☐ Administrative إداري	☐ Patient مريض
☐ Nursing Aid مساعد ممرضة	☐ Technician فني	☐ Security فرد أمن	☐ Other أخرى

OCCURRENCE INFORMATION

Date of Incident تاريخ الحادث	Time of Incident وقت وقوع الحادث	Location/Unit الوحدة/المكان
Name of Person Involved اسم الشخص المعني	Patient ID: رقم الملف الطبي	☐ Female أنثى ☐ Male ذكر

Briefly describe the incident/ occurrence and attach the supporting data when applicable
 وصف ملخص للحادث مع الدعم بمستند إذا أمكن

Immediate Corrective Action taken: To be completed by involved/concerned department
 الإجراء التصحيحي المتخذ : يتم كتابته من قبل الشخص المسئول

Suggested Preventive Action: To be completed by the concerned Head of Department for follow up
 الإجراء التصحيحي المقترح : يتم كتابته من قبل رئيس القسم الملحق

Name: التاريخ: الوقت: التوقيع:

O.V.R. 1-2